

Ordonnances types pédiatriques

Sommaire du fichier :

1. Angines.....	P2
2. Rhinopharyngite / Obstruction nasale.....	P5
3. Bronchiolite.....	P6
4. Laryngite.....	P8
5. Épiglottites.....	P10
6. Otites.....	P12
7. Sinusite.....	P16
8. Vomissements.....	P17
9. Diarrhée légère.....	P18
10. Gastroentérite aiguë + déshydratation....	P19



1- Angines :

Définition :

- **Angine = amygdalite = infection douloureuse et fébrile des amygdales.**
- **Infections ORL les plus fréquentes de l'enfant avec les otites, pic d'incidence entre 5 et 15 ans.**
- **Angine virale (plus fréquente) : adénovirus, influenzae, parainfluenzae, VRS, EBV.**
- **Angine bactérienne (habituellement seulement > 3 ans) due à :**
 - **CG+ : SBHA / Pneumo**
 - **Petit BGN : HI**

Diagnostic clinique :

signes cliniques :

- **Odynophagie.**
- **Fièvre.**
- **Amygdales congestives et hypertrophies.**
- **ADP associées.**

Signes associés inconstants :

- **Toux.**
- **Rhinorrhée.**
- **Myalgie.**
- **Conjonctivite.**
- **Éruptions cutanées.**

Angine virale	Angine à strepto A
● <i>Environnement : épidémie</i> ● <i>A tout âge</i> ● <i>Début progressif, fièvre variable, odynophagie modérée</i> ● <i>Aspect érythémateux ± vésicules</i> ● <i>Toux, rhinorrhée, myalgie, conjonctivite, éruption cutanée</i>	● <i>En hiver/début de printemps</i> ● <i>De 3 à 15 ans, avec un pic de fréquence à 5 ans</i> ● <i>Début brutal, fièvre élevée, odynophagie intense</i> ● <i>Érythème pharyngé intense,</i> ● <i>purpura du voile</i> ● <i>ADP cervicale sensibles</i>

Traitement :

Angines virales : traitement symptomatique

1- Efferalgan sirop _____ 1 FLC

1 ddp × 4 / jour en cas de fièvre

2- SSI 9% _____ 1 FLC

Instillation fréquente

NB : Posologie du paracétamol 60 mg / Kg / Jour en 4 prise chaque 6H.

RDV de contrôle après 48H .

Angines bactériennes : ATB ++

1ère intention :

Amoxicilline (50 -100 mg / Kg / Jour en 3 prise) _____ QSP 6 J

1 ddp × 3 / Jour

Si allergie à la pénicilline :

C2G :

Céfuroxime - axétil :

Zinnat sirop _____ QSP 5 J

30 mg / kg / jour en 2 prise

ou Zynax sirop _____ QSP 6 J

1 ddp × 2 / J pendant 6J)

C3G :

Céfixime ou Cefdinir :

Oroken 8 mg / Kg / J en 2 prises _____ QSP 6 J

Omnicef 1 ddp × 2 / J en 2 prise _____ QSP 6 J

Si allergies aux Bêta Lactamine :

Macrolides :

- Azithromycine

Zomax sirop 40 mg _____ Pdt 3J

1 ddp / J

- Clarithromycine :

Zeclar ou Huclar 25 mg / 50 mg _____ Pdt 6J

1 ddp × 2 / J

Josacine Retiré du marché Algérien

+ TRT Symptomatique :

- Efferalgan

- SSI

NB : L'alpha-amylase (Maxilase° ou autre), une enzyme sans efficacité démontrée au-delà de celle d'un placebo dans les maux de gorge, expose à des troubles cutanés ou allergiques parfois graves, dont : urticaires, prurits, angioœdèmes, rashes maculopapuleux, érythèmes (n° 426 p. 256).

La source :

file:///C:/Users/Sc/Downloads/Pour_mieux_soigner_des_medicaments_a_ecarter___bilan_2024.pdf

- NB : Les AINS et CTC N'ont aucune indication
- Si suspicion H.I → Augmentin en 1ère intention
- Augmentin utilisé en cas de cpc : phlegmon (S'il existe un phlegmon, leur traitement sera : Un drainage + Augmentin 10jrs OU C3G)

2- Rhinopharyngite :

définition:

- *Atteinte inflammatoire du cavum (pharynx) et des fosses nasales .*
- *Infection bénigne et fréquente.*
- *1ere pathologie infectieuse et 1ere cause de consultation en pédiatrie.*

Physiologie:

- *N.né + NRS*
- *Anatomique : cou court ; trompes d'eustache courtes*
- *ventilation nasale exclusive jusqu'à 12 semaine*
- *Adaptation immunitaire jusqu'à 7 ans*

Diagnostic : Clinique

Rhinite :

- *écoulement nasale*
- *+/- toux en cas d'atteinte bronchique associé*

Pharyngite :

- *muqueuses rouge, oedémateuse*
- *Signes associés (inconstants) : fièvre , ADP , Otite congestive*

NB: Le caractère puriforme de la rhinorrhée et la fièvre ne sont pas synonyme d'infection bactériennes

Complication Bactériennes:

- *OMA purulente*
- *Conjonctivite purulente*
- *Sinusite aiguë*

Traitement:

- *Désobstruction nasale ++++*
- *Antalgique /antipyrétique (paracétamol 60 mg /kg/24H en 4 prises.*

3-Bronchiolite Aiguë :

Définition :

- *Inflammation aiguë des bronchioles.*
- *Bronchopathie obstructive, essentiellement d'origine infectieuse chez le nourrisson < 12 mois.*
- *premier épisode aigu de gêne respiratoire, à toute période de l'année, < 12 mois.*
- *Agent infectieux : VRS ++ (60-70%), rhinovirus (20%), parainfluenzae.*

Facteurs de risques :

- *Prématurité < 35 semaines.*
- *Age < 06S.*
- *Pathologie cardiaque ou neuromusculaire adjacente.*
- *Mauvaises conditions socio-économiques.*

Signes de gravité :

- *Polypnée > 70 cycles /min.*
- *Signes de lutte : battement des ailes du nez, tirage intercostal, Sous costal, Sus sternal.*
- *Gêne à l'alimentation (↓50%).*
- *Cyanose.*
- *SaO2 < 90%.*
- *AEG, geignement.*
- *Agitation ou au contraire léthargie, perte de conscience.*
- *Troubles digestifs, vomissements, diarrhées profuses.*
- *Signes d'épuisement, apnées*

Bronchiolite			
Pas de signes de gravité, ni de FDR	Pas de signes de gravité FDR+		Signes de gravité ± FDR
PEC ambulatoire	Observation 2 – 4h		Hospitalisation
Mesures de soutien • Moucher • Hydrater • Fractionner les repas • Apprendre aux parents les signes de gravité	Stable ↔	Signes de gravité ⇒	• Mouchage • Hydrater • Alimenter (IV, fractionné, sonde) Oxygène : but : SO ₂ > 92% Critères de sortie : • Absence de signes de gravité • Prise orale > 75% • SO₂ > 92%

Ordonnance pour :

- **Rhinopharyngite**
- **Obstruction nasale**
- **Bronchiolite légère (sans FDR, sans sg de gravité)**
- **Angine virale**

1- Efferalgan sirop _____ 1 FLC

1 ddp × 4 / jour en cas de fièvre

ou

Doliprane suppo(*)mg _____ 1 BTE

1 suppo × 4 / j en cas de fièvre

2- SSI 9% _____ 1 FLC

Instillation fréquente

NB : Posologie du paracétamol 60 mg / Kg / Jour en 4 prise chaque 6H

RDV de contrôle après 48H .

4- Laryngites :

Définition : Inflammation du larynx (étage sous glottique = cordes vocales), le plus souvent d'origine infectieuse.

Diagnostic clinique :

Syndrome dyspnéique :

- Cyanose
- Diminution de la SaO²
- Signes de lutte : Tirage sus sternal, intercostal, battement des ailes du nez
- Dyspnée inspiratoire

Syndrome dysphonique :

- Stridor (bruit aigu)
- Toux aboyante
- Cornage (bruit grave)
- Voix rauque, voir aphonie
- Signes associés R.P

Score de WESTLEY :

Degré de conscience	Normal	0
	Altéré	5
Cyanose	Absente	0
	À l'agitation	4
	Au calme	5
Murmure vésiculaire	Normal	0
	Diminué	1
	Très diminué	2
Tirage	Aucun	0
	Léger	1
	Modéré	2
	Sévère	3
Stridor inspiratoire	Absent	0
	À l'agitation	1
	Au calme	2

Résultats :

Légère : score = 1

Modérée : score 2-7

Sévère : score ≥ 8

Ordonnance pour Laryngite :

1) Corticoïdes :

Prednisolone (0.5 à 2 mg / kg / jr) _____ 1 Flc

en 1 ou 2 prises / jr

ou Prédo 15 mg/ml _____ 1 Flc

Poids de l'enfant / 3 : en ml (1mg/kg/jr) :

01 ddp en (ml) 1mg/kg/j le matin

1/2 ddp le soir pendant 05 jours

2) Augmentin sirop _____ qsp 6 jrs

1 ddp $\times$ 3 / jr

3) Efferalgan sirop _____ 1 Flc

1 ddp $\times$ 4 / jr en cas de fièvre

4) Optionnel : Anti tissuif + Anti histaminique

Deslor sirop _____ 1Flc

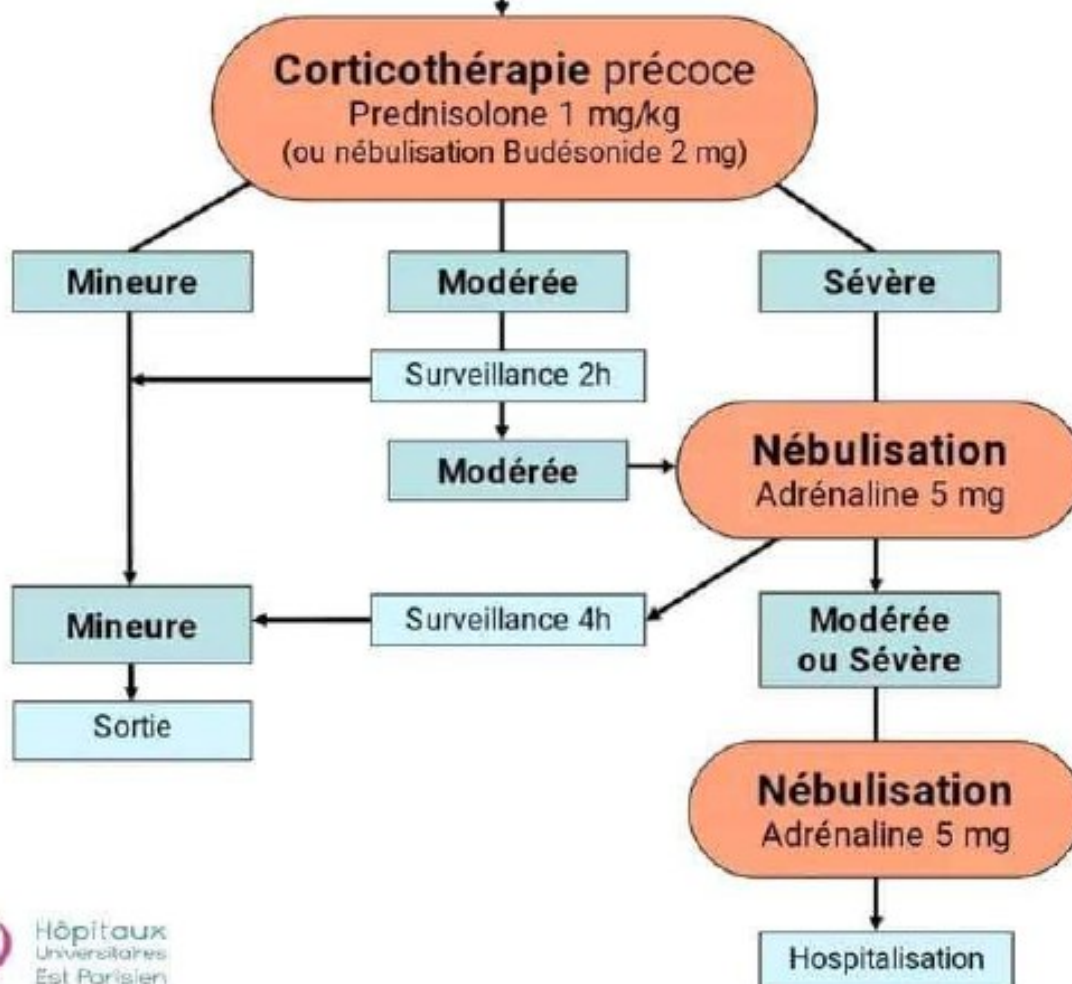
1.25 ml / 5 kg de poids le soir

NB : Dose de CTC IV ou inhalée au pu si nécessaire .

Laryngite aiguë

Installer confortablement l'enfant
(laisser le, s'il le veut, sur les genoux des parents ou dans les bras)
Evaluer ABC et prise en charge (+/- MHC)

Score	Mineure	Modérée	Sévère
Toux rauque	Occasionnelle	Fréquente	Fréquente
Stridor au repos	Absent	Présent	Présent insp +/- exp
Tirage sus sternal	Absent ou minime	Au repos	Marqué
Tirage intercostal	Absent	Absente ou minime	Présente
Agitation	Absente	Absente ou minime	Présente



5- Épiglottite : URGENCE !!!

Définition :

- *L'épiglottite est une inflammation de l'épiglotte (située au sommet du larynx), causée par une infection bactérienne.*
- *La bactérie la plus souvent retrouvée dans ce type d'infection est H.influenzae de type B.*

Clinique :

- *Enfant entre 2-6 ans très agité.*
- *penché en avant.*
- *hypersialorrhée.*
- *Contre indication de l'utilisation de l'abaisse langue ou d'allonger l'enfant.*

PEC :

- *Hospitalisation en urgence.*
- *CTC .*
- *ATB en IV.*
- *Intubation voire trachéotomie.*

Faites attention :

" On force jamais l'enfant à s'allonger s'il refuse la position couchée on l'oblige pas et on utilise jamais l'abaisse langue ".

6-Otites :

- *Motif de consultation très fréquent chez le nourrisson et le petit enfant.*
- *Le motif de consultation : Otalgie.*
- *L'otite la plus fréquente c'est l'otite moyenne (OMA).*
- *Otite Aiguë -----> on la traite.*
- *Otite Chronique -----> orientation vers un spécialiste.*

OMA :

- *la plus fréquente.*
- *Elle est plus fréquente chez le nrs et le petit enfant (vue son anatomie du sphère ORL).*
- *Dans l'OMA y'a une pression - qui aspire le tympan.*

---> Aspect du tympan : Rouge, congestif, rétracté et bombé

- Les 03 Stades de l'OMA :
 - Stade 01 : Tympan rouge congestif
Otalgie +++
 - Stade 02 : Tympan purulent
Otalgie intense +++++++
 - Stade 03 : Perforation (le pus sort du tympan)
Pas de douleur (le malade se sent bien)

Traitement :

1- ATB : EN pratique dans les 03 stades on donne un ATB qui vise les germes responsables de L'OMA (pneumocoque, Haemophilus, Moraxella)

Augmentin (50 -100 mg / Kg / Jour en 3 prise) _____ QSP 6 J

1 ddp × 3 / Jour

Si le patient est allergique au pénicilline, on lui donne C2G :

C2G :

Céfuroxime - axétil :

Zinnat sirop _____ QSP 5 J

30 mg / kg / jour en 2 prise

ou Zynax sirop _____ QSP 6 J

1 ddp × 2 / J pendant 6J)

C3G :

Céfixime ou Cefdinir :

Oroken 8 mg / Kg / J en 2 prises _____ QSP 6 J

Omnicef 1 ddp × 2 / J en 2 prise _____ QSP 6 J

Si allergie aux bêta-lactamines, on lui donne:

Macrolides :

- Azithromycine

Zomax sirop 40 mg _____ Pdt 3J

1 ddp / J

- Clarithromycine :

Zeclar ou Huclar 25 mg / 50 mg _____ Pdt 6J

1 ddp × 2 / J

Antalgique + Antipyrétique: dans l'OMA, la fièvre n'est pas constante.

2-Efferalgan:

Sirop: poids < 30 kg.

**Doliprane cp 500 mg:
30 < poids > 60 kg.**

**Doliprane cp 1g:
poids > 60 kg.**

en 3 à 4 prises / jour.

3-Les gouttes auriculaires:

S1 + S2: le tympan est intact + otalgie ++.

- **Otipax ou Oricalm _____ 1 Bte**

02 gttes × 3 / jr pdt 2 à 3 jrs.

Ils sont CI en cas de perforation du tympan.

S3: Tympan perforé : On donne des gttes ATB.

Otofa (Rifamycine) ou Préparation collyrique (pour l'adulte et l'enfant).

la Préparation:

Chibroxine collyre _____ 01 flc pdt 5 jrs.

02 gttes × 3 / jr

Solumédrol 20 mg _____ 01 flc pdt 5 jrs.

02 gttes × 3 / jr

La durée: 5 / 7 / 10 jours.

NB: les gouttes sont utilisées dans l'oreille malade seulement, on préfère la préparation, car l'otofa peut masquer la couleur du tympan à cause de sa couleur. S'il y'a pas d'amélioration et persistance des symptômes, on traite l'étiologie: obstruction nasale, rhinite, pharyngite... etc

Si Rhinite:

Age < 6 ans:

instillations SSI 9 % fréquentes ou eau de mer.

Age > 6 ans:

pulvérisations nasales:

CTC nasaux: Nasocort, Rhinocort, Flixonase, Nasonex.

< 12 ans: _____ 01 pulv / narine / j le matin.

> 12 ans: _____ 02 pulv / narine / j le matin.

Si le terrain est allergique, on lui donne un antihistaminique :

- **âge < 2 ans: Histagon ½ cà m le soir.**
- **age > 2 ans: Primalan ½ cà m le soir.**
- **âge > 4 ans: Tifen 1 cà m le soir.**
- **age > 12 ans: Telfast cp 120 mg 01 cp / jr le soir.**

Ou Ebasta cp 10 mg 01 cp / jr le soir.

7-Sinusite :

définition : inflammation du sinus (frontal , ethmoïde , maxillaire) due à l'obstruction du sinus et au défaut de communication aérienne .

Signes cliniques :

1. Céphalées
2. Douleur orbitaire
3. Obstruction nasale
4. Ecoulement

- Le diagnostic est clinique ,
- TDM est indiqué seulement en cas de complication (ethmoïdite extériorisée) .
- Les germes responsables sont les mêmes que ceux de l' OMA , donc le même traitement .
- Les pulvérisations nasales sont obligatoires .
- CTC par voie orale :

Solupred cp 5 mg , 20 mg

1mg/kg/jr en prise unique le matin

pas de dose max (durée 5 jours)

chez l'adulte la durée du traitement est de 6 jours .

- **CPC :** ethmoïdite surtout chez l'enfant , elle est grave et mortelle .

Oedème palpable d'évolution rapide

- **Diagnostic différentiel :** Piqûre d' insecte , on cherche le point de piqûre , si on trouve rien on l'oriente vers l' ORL en urgence , car c'est une ethmoïdite J.P.C .
- On demande TDM du sinus pour confirmer et graduer le diagnostic .
- Le traitement est selon le stade (drainage ... etc) .

NB : L'ethmoïdite généralement est unilat .

Elle commence par l' angle sup iut du paupière > puis < puis une exophtalmie .

8- Ordonnance pour vomissements :

1) SRO à volonté

2) Antiémétique :

< 2 ans :

Vomiteb sirop _____ 1 Flc

1 càc × 3/jr 20 min avant les repas

> 2 ans :

• Dompérone sirop _____ 1 Flc

1 ddp × 3/jr

• Vogalene suppo _____ 1 Bte

1 suppo × 3 / jr

> 16 ans :

• Métoclopramide (primperan)

• MIGPRIV

9- Ordonnance pour diarrhée légère

(sans signes de déshydratation):

1) SRO à volonté

2) Antidiarrhéique :

< 2 ans :

Racécadotril (Tiorfan) _____ 1 bte

2 sac à la fois + 1 sac × 3/ J

NRS : 10 mg

Enfant : 30 mg

> 2 ans :

Loperamide (Inphadium) Sirop _____ 1 FLC

1 ddp × 2 / J

OU

Smecta (Diosmectite) _____ 1 bte

1 sac × 3/ J

10- Gastroentérite Aiguë + Déshydratation :

Signes DH2O Extracellulaires :

- *Pli cutané*
- *Dépression de la FA*
- *Yeux cernés et excavés*
- *Absence de larmes*
- *Signes de choc hypovolémique*

Signes DH2O Intracellulaires :

- *Soif*
- *Sécheresse des muqueuses*
- *Fièvre inexpliquée*
- *Somnolence , troubles de la conscience .*

PEC :

1. Bilan : FNS ; IONO ; Bilan Rénal ; Glycémie capillaire
2. Schéma de réhydratation :

Phase 1 : le but est de restaurer 50% des pertes Antérieures

- [0 - 30 min] : 20 cc / Kg _____ SSI
- [30 min - 2 H] : 30 cc / Kg _____ SSI

→ chimie des urines

Phase 2 : Restaurer les autres 50% des pertes

- [2H - 6 H] : 50 cc / Kg = SIR

→ Iono de contrôle

- [6H - 24H] : Ration de base

100 cc / Kg = SIR

+ SRO + TRT symptomatique et RDV de contrôle .

